

Hemorragia Digestiva Alta y Baja

1. Introducción y relevancia clínica

La **hemorragia digestiva (HD)** es una de las urgencias médicas más frecuentes en gastroenterología y medicina interna. Se define como la pérdida de sangre originada en cualquier punto del tubo digestivo, que puede manifestarse en forma aguda o crónica.

Se clasifica de acuerdo a su localización en:

- **Hemorragia Digestiva Alta (HDA):** sangrado proximal al ligamento de Treitz (esófago, estómago y duodeno).
- **Hemorragia Digestiva Baja (HDB):** sangrado distal al ligamento de Treitz (yeyuno, íleon, colon y recto).

La distinción es fundamental porque determina la etiología probable, el abordaje diagnóstico y la estrategia terapéutica.

La HDA es mucho más frecuente, representando aproximadamente el **80–85 % de los casos de hemorragia digestiva aguda**, y se asocia a mortalidad cercana al 5–10 %, especialmente en adultos mayores o pacientes con comorbilidades.

Por su parte, la HDB es menos común pero puede ser masiva, requiriendo manejo hospitalario y colonoscopia de urgencia.

En Chile, las causas más frecuentes de HDA son la **úlcera péptica, la gastritis erosiva y la ruptura de várices esofágicas**; mientras que la HDB suele deberse a **diverticulosis, angiodisplasias o hemorroides**.

En el **EUNACOM**, este tema es muy preguntado por su alta prevalencia, su manejo inicial en urgencia y por integrar conocimientos de fisiopatología, endoscopía y reanimación.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Hemorragia Digestiva Alta

En la mayoría de los casos, la HDA resulta del **daño de la mucosa gastroduodenal** que erosiona un vaso sanguíneo subyacente.

Entre las causas más relevantes destacan:

- **Úlcera péptica:** erosión profunda de la mucosa por desequilibrio entre los factores agresivos (ácido, pepsina, *H. pylori*, AINEs) y los defensivos (moco, bicarbonato).
- **Erosiones gástricas o duodenales:** lesiones superficiales por AINEs, alcohol o estrés.
- **Várices esofágicas o gástricas:** consecuencia de hipertensión portal, donde el aumento de la presión venosa dilata los vasos submucosos del esófago, predisponiéndolos a ruptura.
- **Síndrome de Mallory-Weiss:** laceración mucosa en la unión gastroesofágica tras vómitos repetidos.

El sangrado puede ir desde microhemorragias autolimitadas hasta sangrados masivos que comprometen la estabilidad hemodinámica.

Hemorragia Digestiva Baja

En la HDB, la fisiopatología depende del sitio y causa del sangrado.

Las etiologías más comunes incluyen:

- **Diverticulosis colónica:** pequeños sacos mucosos en el colon que pueden erosionar vasos arteriales.
- **Angiodisplasias:** malformaciones vasculares degenerativas del colon derecho.
- **Enfermedad inflamatoria intestinal:** ulceraciones que pueden sangrar crónicamente.
- **Cáncer colorrectal o pólipos adenomatosos.**
- **Hemorroides y fisuras anales:** causas frecuentes de sangrado rojo rutilante en menores de 50 años.

En general, los sangrados altos se manifiestan con vómito de sangre (hematemesis) o deposiciones negras (melenas), mientras que los sangrados bajos se manifiestan con hematoquezia (sangre roja o vinoso oscuro en heces).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Hemorragia Digestiva Alta

Síntomas principales:

- **Hematemesis:** vómito de sangre roja fresca o con aspecto “en posos de café”.
- **Melenas:** deposiciones negras, alquitranadas y de olor fétido.
- **Signos de hipovolemia:** taquicardia, hipotensión, palidez, diaforesis, compromiso de conciencia en casos graves.

Otros síntomas orientadores:

- Dolor epigástrico o historia de dispepsia → sugiere úlcera péptica.
- Antecedente de vómitos reiterados → sugiere Mallory-Weiss.
- Cirrosis, hepatomegalia o ascitis → sugiere várices esofágicas.

Diagnóstico diferencial:

- Epistaxis posterior con deglución de sangre.
 - Hemoptisis (tos con sangre).
 - Ingesta de hierro o alimentos oscuros (falsas melenas).
-

3.2. Hemorragia Digestiva Baja

Síntomas principales:

- **Hematoquezia:** sangre roja o vino tinto mezclada o superficial en las heces.
- **Sangrado rectal aislado:** orienta a hemorroides o fisuras.
- **Melena:** ocasional si el sangrado proviene del intestino delgado o colon proximal.
- **Signos de anemia o hipovolemia:** palidez, taquicardia, lipotimia.

Antecedentes relevantes:

- Cambios en hábito intestinal o pérdida de peso → sospecha de cáncer colorrectal.
- Dolor abdominal tipo cólico + diarrea con sangre → sugiere colitis infecciosa o inflamatoria.

- Pacientes mayores con insuficiencia renal o aórtica → angiodisplasia.
-

4. Evaluación inicial y exámenes complementarios

El primer paso ante cualquier hemorragia digestiva es evaluar **gravedad y estabilidad hemodinámica**.

Evaluación clínica inicial

- Signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación.
- Búsqueda de signos de shock: palidez, sudoración, alteración del sensorio.
- Colocar dos vías venosas periféricas de grueso calibre.
- Iniciar fluidoterapia con cristaloides.
- Determinar tipo y grupo sanguíneo, hematocrito y hemoglobina.

Exámenes básicos

- **Hemograma completo:** anemia, plaquetas.
- **Tiempo de protrombina y TTPA:** evaluación de coagulopatía.
- **Creatinina y electrolitos:** repercusión sistémica.
- **Pruebas hepáticas:** especialmente si sospecha de cirrosis o várices.
- **Test de orina:** descartar hematuria.

En pacientes con sospecha de sangrado digestivo activo y shock, la prioridad es la **reanimación**, no los exámenes.

5. Diagnóstico endoscópico

Endoscopía digestiva alta (EDA)

Es el examen de elección para la **HDA**, permitiendo **diagnóstico y tratamiento simultáneo**.

Debe realizarse idealmente dentro de las **primeras 24 horas** tras estabilizar al paciente.

Permite identificar la causa (úlceras, várices, erosión, Mallory-Weiss) y aplicar tratamiento endoscópico (adrenalina, esclerosis, bandas o clips).

Hallazgos endoscópicos de riesgo (Forrest):

- Sangrado activo visible.
- Vaso visible no sangrante.
- Coágulo adherido.
- Base limpia (bajo riesgo de resangrado).

Colonoscopia

Es el examen de elección en la **HDB** una vez estabilizado el paciente.

Debe realizarse tras preparación intestinal con polietilenglicol.

Permite diagnosticar y tratar lesiones sangrantes (divertículos, angiodisplasias, pólipos).

En casos de sangrado activo masivo, puede requerirse **angiografía mesentérica** o **gammagrafía con glóbulos rojos marcados**.

6. Tratamiento (según MINSAL y guías internacionales)

6.1. Manejo inicial general

1. **Reanimación hemodinámica:**
 - Cristaloides isotónicos (suero fisiológico o Ringer lactato).
 - Transfusión de glóbulos rojos si Hb <7 g/dl (o <9 g/dl en pacientes con cardiopatía).
 - Oxigenoterapia.
 2. **Suspender AINEs, aspirina y anticoagulantes si es posible.**
 3. **Monitorización en unidad de observación o UCI** en casos graves.
-

6.2. Hemorragia Digestiva Alta

A. Manejo específico según causa:

- **Úlcera péptica / erosión:**

- Iniciar **inhibidor de bomba de protones (IBP)** IV: omeprazol 80 mg en bolo + infusión continua 8 mg/hora por 72 h.
 - Luego continuar con IBP oral por 4–8 semanas.
 - Si *Helicobacter pylori* positivo → erradicar con esquema triple (IBP + amoxicilina + claritromicina).
 - **Várices esofágicas:**
 - Iniciar **terapia vasoactiva inmediata:** octreótido 50 µg en bolo, seguido de infusión continua 50 µg/hora por 3–5 días.
 - **Antibióticos profilácticos:** ceftriaxona 1 g/día por 7 días.
 - **Endoscopia urgente (<12 h)** para ligadura con bandas.
 - En fracaso terapéutico: considerar **TIPS (derivación portosistémica intrahepática)**.
 - **Mallory-Weiss:** generalmente autolimitado; si persiste, aplicar inyección de adrenalina o clip endoscópico.
-

6.3. Hemorragia Digestiva Baja

A. Medidas iniciales:

- Reanimación igual que en HDA.
- Valorar necesidad de transfusión.
- Monitorizar diuresis y signos vitales.

B. Tratamiento específico según etiología:

- **Diverticulosis:** la mayoría se autolimita; si persiste, se realiza hemostasia endoscópica (inyección, clip o coagulación).
- **Angiodisplasias:** coagulación con argón plasma durante colonoscopia.
- **Enfermedad inflamatoria intestinal:** corticoides y control del brote.
- **Hemorragia masiva persistente:** angiografía con embolización selectiva o cirugía.

C. Prevención de recurrencias:

- Controlar factores predisponentes (AINes, anticoagulantes).
 - Tratamiento de comorbilidades (insuficiencia renal, cirrosis).
-

7. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones:

- Shock hipovolémico y falla multiorgánica.
- Perforación gástrica o duodenal (úlceras).
- Resangrado (10–20 % de los casos de HDA).
- Encefalopatía hepática en cirróticos tras HDA variceal.
- Isquemia mesentérica o necrosis colónica (en HDB masiva).

Pronóstico:

Depende de la causa, edad, comorbilidades y tiempo hasta la atención.

Con diagnóstico y tratamiento oportunos, la mortalidad global es <10 %.

Los pacientes con cirrosis o cáncer gastrointestinal tienen peor pronóstico.

8. Prevención

1. **Uso racional de AINEs:** asociar IBP en pacientes con riesgo alto.
 2. **Erradicación de H. pylori en úlcera péptica.**
 3. **Profilaxis de várices esofágicas:** betabloqueadores no selectivos (propranolol o carvedilol).
 4. **Evitar alcohol y tabaco.**
 5. **Tamizaje de cáncer colorrectal** en adultos mayores de 50 años (colonoscopia cada 10 años).
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **melena** indica sangrado digestivo alto, incluso con Hb normal inicial.
2. **Hematoquezia + shock** puede corresponder a HDA masiva (no siempre a HDB).
3. El manejo inicial siempre es **reanimar primero, endoscopiar después.**

4. En HDA variceal → iniciar **octreótido y antibióticos antes de endoscopia**.
5. En úlcera péptica → administrar IBP IV de inmediato.
6. La **endoscopia precoz (<24 h)** reduce mortalidad y necesidad de cirugía.
7. La **colonoscopia** es el estudio de elección en HDB estable.
8. En EUNACOM, se evalúan manejo inicial, diagnóstico diferencial y tratamiento según causa.

Errores comunes:

- Retrasar reanimación por solicitar exámenes.
 - No suspender AINEs o anticoagulantes.
 - Administrar antieméticos o proquinéticos sin estabilizar al paciente.
 - Indicar IBP oral en lugar de IV en HDA activa.
 - No hospitalizar a pacientes con sangrado reciente y comorbilidades.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **hemorragia digestiva alta** es más frecuente y potencialmente grave; su diagnóstico y manejo inicial son urgencias vitales.
2. El **síntoma cardinal** es la hematemesis o melena; la **endoscopia precoz** permite diagnóstico y tratamiento simultáneo.
3. En la **HDA variceal**, el manejo incluye **octreótido, antibióticos y ligadura endoscópica**.
4. La **hemorragia digestiva baja** se manifiesta por hematoquezia y requiere colonoscopia.
5. La **reanimación hemodinámica** siempre precede a los procedimientos diagnósticos.
6. Los **IBP IV** son pilar del tratamiento de la úlcera péptica sangrante.
7. La **prevención** se basa en evitar AINEs, tratar *H. pylori* y controlar la hipertensión portal.